

TEMA 5.9 • OFTALMOLOGÍA

pérdida lenta de visión

PERFIL EUNACOM 2.01.1.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Infecciones Palpebrales Severas: Celulitis Preseptal vs. Orbitaria

Saber diferenciar entre una **Celulitis Preseptal** (preorbitaria) y una **Celulitis Orbitaria** (postseptal) es vital. La primera es frecuente y de manejo médico primario-ambulatorio, mientras que la segunda es una emergencia médica profunda, puesto que amenaza la visión del paciente e incluso la vida mediante invasión a sistema nervioso central.

Criterios Clínicos Comunes

En ambas patologías la cara superficial es parecida: - Gran aumento de volumen en el párpado y área periorbital. - **Edema** muy acentuado (muchas veces sella o cierra el ojo mecánicamente). - Fuerte **Eritema**, induración clínica y calor local.

Criterios Diferenciadores de Gravedad (Reconociendo la Orbitaria)

Para diagnosticar la temida e invasiva **Celulitis Orbitaria**, basta con pesquisar y constatar **tan sólo UNO** de los siguientes síntomas y/o signos intraorbitarios durante la semiología.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Banderas Rojas - Signos de Celulitis Orbitaria: Cualquier caso periorbitario inflamado que además asocie una de estas características se reclasifica inmediatamente como Orbitaria: 1. **Proptosis (Exoftalmos):** El globo ocular protruye por inflamación retrobulbar. 2. **Disminución de la agudeza visual.** 3. **Oftalmoparesia / Oftalmoplejía:** Falla restrictiva e indeseable en los músculos oculomotores. 4. **Dolor con los movimientos oculares:** Sugiere fuertemente inflamación intraconal/extraconal en la propia cavidad orbitaria envolviendo a los músculos. 5. **Alteración de reflejos pupilares:** Vía oftálmica afectada, caída o anomalía del reflejo fotomotor. 6. **Quemosis franca:** Gran edema abombado de la conjuntiva bulbar del propio globo (no sólo del párpado).

Etiología Frecuente

- Ambos cuadros suelen sobreponerse en sus etiologías en dos grandes contextos clínicos:
- **Extensión secundaria (por vecindad):** La causa más importante, especialmente de la orbitaria, es la complicación de una grave y arrastrada purulencia por sinusitis maxilar o, característicamente, etmoidal.
- **Puerta de Entrada Dérmica local:** Una inoculación a través de una herida y excoriación de piel superciliar, o una complicación masiva secundaria a chalazión/orzuelos mal manejados.
- **Bacteriología Predominante:**
 - - *Streptococcus pneumoniae* (Neumococo), habitualmente viniendo de la extensión sinusal.
 - - *Staphylococcus aureus*

Abordaje y Tratamiento

Celulitis Preseptal (Preorbitaria)

Constituye un abordaje generalmente seguro por un médico general tras un examen minucioso. - **Estado Sistémico:** Paciente estable. - **Tratamiento:** **Antibióticos orales** con cobertura a Cocos Gram Positivos. - **Fármaco de Elección:** **Amoxicilina/Ácido Clavulánico** por vía oral, control clínico a las 24-48 h. - Instruir estrictamente a los familiares sobre los signos de alarma y re-consultar de inmediato si aparece alguno de los 6 signos pélvicos de progresión (Dolor al mover el ojo, hinchazón del globo, alteraciones visuales, etc).

Celulitis Orbitaria (Postseptal)

Una vez identificada la bandera roja, no puede ser despachado al hogar. El paciente requiere ingresar al área de urgencias de mayor complejidad. - **Gravedad Médica:** Riesgos severos incluyen trombosis de senos cavernosos, meningoencefalitis, absceso de cerebro y pérdida funcional del nervio óptico. - **Neuroimagen Empírica:** Obliga a realizar **Tomografía Computarizada (TAC) orbitaria y senos paranasales** con ventana ósea, para identificar focos causales (como sinusitis), abscesos intralesionales profundos susceptibles de drenaje quirúrgico y para delimitar la anatomía periorbitaria. - **Tratamiento:** Antibióticos bactericidas intravenosos cruzando barrera del sistema nervioso de muy **amplio espectro**, a dosis plenas. - Clásicamente esquema inicial agresivo de: **Ceftriaxona IV** (Neumococo y H. Influenzae) + **Vancomicina IV** (S. aureus MRSA) - Es común agregar Metronidazol en adultos si se infiere un anaerobio sinusal en sinusitis crónicas purulentas. - Tratamiento urgente por infectología/ofthalmología.

EUNACOM CRITERIOS

Regla Dorada: Ante un paciente en el cual usted tenga cualquier pequeña sospecha o duda legítima de un signo dudoso de celulitis orbitaria (por ej. limitación mínima inespecífica del ojo o reflejo alterado mínimo), **asuma, trate y derive siempre** calificándolo como Celulitis Orbitaria hasta que la imagen demuestre lo contrario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de setenta y dos años consulta por visión borrosa bilateral progresiva de dos años. Refiere deslumbramiento con las luces de los automóviles en la noche y cambios en la percepción del color. Al examen se observa disminución del reflejo rojo en ambos ojos. La presión intraocular es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para pérdida lenta de visión. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las cataratas son opacificación del cristalino, principal causa de ceguera reversible en el mundo, tratamiento con facoemulsificación cubierta por GES en Chile.
- La degeneración macular seca produce drusas y pérdida progresiva de visión central sin tratamiento curativo; la húmeda produce neovascularización y se trata con anti-VEGF intravítreo.
- El glaucoma crónico de ángulo abierto es asintomático hasta etapas avanzadas porque afecta primero el campo visual periférico, es la segunda causa de ceguera mundial.
- El screening del glaucoma crónico se hace con tonometría y se confirma con campimetría para documentar el defecto de campo visual.
- El tratamiento del glaucoma crónico son hipotensores oculares como latanoprost o timolol; los anticolinérgicos están contraindicados porque pueden precipitar un glaucoma agudo.
- Las tres causas de pérdida lenta de visión son: cataratas, degeneración macular relacionada con la edad y glaucoma crónico de ángulo abierto.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PÉRDIDA LENTA DE VISIÓN)

PREGUNTA 1

Un hombre de setenta y dos años consulta por visión borrosa bilateral progresiva de dos años. Refiere deslumbramiento con las luces de los automóviles en la noche y cambios en la percepción del color. Al examen se observa disminución del reflejo rojo en ambos ojos. La presión intraocular es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Glaucoma crónico de ángulo abierto bilateral
- B) Degeneración macular relacionada con la edad
- C) Cataratas bilaterales
- D) Retinopatía diabética bilateral
- E) Neuritis óptica bilateral

PREGUNTA 2

Una mujer de sesenta y ocho años con glaucoma crónico de ángulo abierto diagnosticado hace cinco años consulta a control. Está en tratamiento con timolol. Usted decide agregar un segundo hipotensor. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado en esta paciente?

- A) Latanoprost
- B) Brimonidina
- C) Pilocarpina en dosis de mantenimiento
- D) Atropina sistémica
- E) Dorzolamida

PREGUNTA 3

Un hombre de setenta años consulta por dificultad para leer y ver la televisión de seis meses de evolución. Refiere que la visión central está borrosa y distorsionada, especialmente cuando lee. La visión periférica está conservada. Al examen del fondo de ojo se observan depósitos amarillentos en la región macular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Glaucoma crónico de ángulo abierto
- B) Degeneración macular relacionada con la edad, forma seca
- C) Catarata nuclear
- D) Oclusión de rama venosa retiniana
- E) Neuropatía óptica isquémica

RESUMEN: PÉRDIDA LENTA DE VISIÓN

La pérdida lenta de visión es uno de los motivos de consulta oftalmológica más frecuentes en adultos y tiene tres causas principales que el médico general debe conocer: cataratas, degeneración macular relacionada con la edad y glaucoma crónico de ángulo abierto. Las cataratas son la opacificación del cristalino y constituyen la principal causa de ceguera reversible en el mundo. La clínica es visión borrosa progresiva, deslumbramiento y cambios en la percepción del color. El diagnóstico es clínico con lámpara de hendidura y la clave diagnóstica al examen general es la opacidad del cristalino visible o la disminución del reflejo rojo. El tratamiento quirúrgico es la facoemulsificación con implante de lente intraocular y en Chile está cubierto por el GES. La degeneración macular relacionada con la edad afecta la mácula y por tanto la visión central. Hay dos formas: la seca, más frecuente y de peor pronóstico en general, caracterizada por depósitos llamados drusas; y la húmeda, menos frecuente pero más agresiva, producida por neovascularización subretiniana y que puede tratarse con inyecciones intravítreas de anti-VEGF. El glaucoma crónico de ángulo abierto es la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Lo más importante es que es absolutamente asintomático hasta etapas avanzadas, ya que afecta primero el campo visual periférico y solo en etapas terminales afecta la visión central. El diagnóstico se hace con tonometría como screening y campimetría para confirmar el defecto del campo visual. El tratamiento es con hipotensores oculares como el latanoprost o el timolol. Los anticolinérgicos están contraindicados porque pueden precipitar un glaucoma agudo.